Dénutrition

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : IMC = indice de masse corporelle · EPA = échelle d'évaluation des prises alimentaires · MNA-SF = mini-évaluation nutritionnelle courte · NRI / GNRI = index de risque nutritionnel (gériatrique) · GLIM = critères internationaux de dénutrition · MAS = malnutrition aiguë sévère · CNO = compléments nutritionnels oraux · NE / NP = nutrition entérale / parentérale · SNG = sonde nasogastrique · SRI = syndrome de renutrition inappropriée · N = azote · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : dénutrition = **≥ 1 critère phénotypique + ≥ 1 critère étiologique** · **albumine = sévérité seulement** · un obèse **peut** être dénutri · besoins : **30-35 kcal/kg/j** et **1,2-1,5 g protéines/kg/j** · **oral → entéral → parentéral** · CNO **à distance** des repas · SNG < 4 semaines, sinon gastrostomie · SRI : **thiamine avant le glucose**, **démarrer bas** (10 kcal/kg/j si haut risque), surveiller **P, K, Mg**.

1. Définitions et mécanismes (41.3 – 41.3.1)

- **Dénutrition** (HAS 2019) = bilan énergétique et/ou protéique **négatif** → modification des fonctions et de la composition corporelle → **pronostic aggravé** · ≈ 2 millions de personnes en France · très fréquente à l'hôpital et en EHPAD.
- Trois mécanismes souvent associés : **apports ↓** (anorexie, dents, dysphagie, isolement, régimes) · **hypercatabolisme** (agression : cytokines, cortisol, glucagon, catécholamines → protéolyse) · **malabsorption et pertes**.
- **Jeûne simple** : insuline ↓, cétose, **épargne des protéines** → perte surtout de graisse → **marasme** (fonte **sans œdème**).
- **Agression** : **pas d'épargne**, fonte musculaire rapide · 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle · albumine ↓ → tableau proche du **kwashiorkor** (**œdèmes**, foie gras, atteinte de la peau et des cheveux).
- Enfant (OMS) : malnutrition aiguë sévère selon le rapport poids/taille, le périmètre brachial ou la présence d'œdèmes · laits thérapeutiques F-75 puis F-100, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi.

2. Conséquences et dépistage (41.3.1)

- Conséquences : **sarcopénie**, chutes, **infections** (immunité ↓), escarres et mauvaise cicatrisation, atteinte cardiaque et respiratoire, intestin, os · chez la personne âgée : **spirale de la dénutrition** (Ferry).
- Dépistage : **peser** à chaque admission et régulièrement · IMC · **% de perte de poids** = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100 · **EPA** < 7 = apports insuffisants · **MNA-SF** (12-14 normal ; 8-11 risque ; 0-7 dénutrition).
- Index : **NRI** utilise le **poids habituel** · **GNRI** utilise le **poids idéal** (Lorentz) · biologie : albumine (demi-vie ≈ 20 jours), transthyrétine (≈ 2 jours), CRP (inflammation).

3. Diagnostic et sévérité (41.3.1)

	Critères (au moins 1 de chaque colonne)
Phénotypiques	perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois · IMC < 18,5 (< 22 après 70 ans) · baisse de la masse ou de la fonction musculaire
Étiologiques	apports réduits · absorption réduite · situation d'agression (inflammation)

- Références : **HAS 2019** (enfant, adulte < 70 ans) · **HAS 2021** (≥ 70 ans) · **GLIM**.
- **Dénutrition sévère** si un critère : IMC ≤ 17 (< 20 après 70 ans) · perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois · albumine ≤ 30 g/L (< 30 après 70 ans).
- L'IMC seul ne suffit pas · l'**obésité sarcopénique** existe.

4. Stratégie de prise en charge (41.3.1)

- **Traiter la cause** · besoins : **30-35 kcal/kg/j** (30-40 après 70 ans), **protéines 1,2-1,5 g/kg/j**.
- Voie **orale** d'abord : conseils, fractionnement, **enrichissement** (poudre de lait, œufs, fromage, beurre, crème), aide au repas · **CNO** (≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour, **à distance des repas**, en plus de l'alimentation).
- **NE** si le tube digestif fonctionne et que la voie orale ne suffit pas : **SNG** si < 4 semaines, **gastrostomie** au-delà.
- **NP** seulement si le tube digestif est inutilisable ou insuffisant.
- **Réévaluer** régulièrement (poids, apports, tolérance) · la renutrition **limite** la fonte musculaire mais ne l'arrête pas tant que l'agression persiste.

5. Syndrome de renutrition inappropriée (41.3.2)

- Mécanisme : la renutrition fait monter l'**insuline** → entrée dans les cellules du **phosphore**, du **potassium**, du **magnésium** + consommation de **thiamine** + rétention d'eau et de sel · survient dans les **2 à 5 premiers jours**.
- Risques : troubles respiratoires, **troubles du rythme**, insuffisance cardiaque, encéphalopathie de Gayet-Wernicke, mort subite.
- **Patients à risque** (NICE) : IMC très bas, perte de poids importante, **jeûne prolongé**, ionogramme bas avant la renutrition, alcoolisme, anorexie mentale…
- Un phosphore sanguin **normal avant** la renutrition **n'élimine pas** le risque (stocks intracellulaires vides).
- **Prévention** : **thiamine avant** tout apport de glucose · **démarrer bas** (≈ 10 kcal/kg/j chez le patient à haut risque, moins encore si risque extrême) puis augmenter progressivement pour couvrir les besoins en 4 à 7 jours · supplémenter et **doser P, K, Mg** souvent les premiers jours · **pesée quotidienne** (une prise rapide de poids = rétention d'eau, signe d'alerte).

Pièges

- IMC < 18,5 seul ne suffit pas : il faut **aussi** un critère étiologique.
- Albumine = **sévérité**, pas diagnostic · un patient obèse **peut** être dénutri.
- Marasme = **sans œdème** · kwashiorkor = **œdèmes**.

- GNRI = **poids idéal** · NRI = poids habituel · transthyrétine ≈ **2 jours**, albumine ≈ 20 jours.
- CNO **entre** les repas · SNG pas pour 3 mois → gastrostomie.
- Hypophosphatémie du SRI = **entrée dans les cellules**, pas perte urinaire.
- Haut risque de SRI : **ne pas** démarrer à 25 kcal/kg/j · +3 kg en 48 h = **eau**, pas muscle.